



TECNOLOGÍA
MÉDICA
CAYETANO

ATENCIÓN PRIMARIA

El terapeuta de lenguaje en el primer nivel de atención

TERAPIA DE LENGUAJE EN
ATENCIÓN COMUNITARIA



7

semana



¿De dónde venimos?



Lo que ya construimos en el curso

Semana 1

APS: fundamentos y principios

Semana 2

Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)

Semana 3

Difusión de la atención comunitaria

Semana 4

Tipos de programas y agentes comunitarios

Semana 5

Tamizajes del lenguaje

Semana 6

Ensayo e infografías



HOY · SEMANA 7

Atención primaria en la práctica del terapeuta de lenguaje



PREGUNTA ORIENTADORA

Ya sabemos la importancia del Tamizaje (S5) y comunicar a la comunidad (S3 y S6). ¿Dónde encajan estas acciones dentro de la atención primaria y cómo se articulan en una ruta: promover, prevenir, detectar, evaluar, intervenir y hacer seguimiento?



Logros de aprendizaje



Al finalizar la sesión, el estudiante:

- 1 **Define** la atención primaria desde la perspectiva de la terapia de lenguaje comunitaria.
- 2 **Explica** las seis características de la AP con un ejemplo aplicado a la comunidad.
- 3 **Diferencia** los niveles de prevención (primaria, secundaria y terciaria) en comunicación.
- 4 **Describe** la ruta de atención: detección, evaluación, intervención, referencia y seguimiento.
- 5 **Propone** acciones de atención primaria para un caso comunitario real o simulado.



Contenido



Atención Primaria

- Definición
- Objetivos
- Características
- Prevención y promoción
- Detección temprana
- Evaluación
- Intervención y tratamiento
- Referencia y seguimiento
- Caso aplicado y actividad





Definición de la atención primaria



La atención primaria en salud comunitaria es el **primer nivel de contacto** entre la persona, la familia y la comunidad con los servicios de salud y educación.

Desde la Terapia de Lenguaje en Atención Comunitaria, implica **llevar los servicios del terapeuta de lenguaje a los contextos donde las personas viven, aprenden y se desarrollan**, para promover, prevenir, detectar, evaluar e intervenir tempranamente en los trastornos del lenguaje, habla, voz, audición y comunicación, con participación activa de la familia y la comunidad.



Primer contacto

Puerta de entrada al sistema



Contexto real

Hogar, escuela, comunidad



Participación

Familia y comunidad activas

Precisión conceptual: la APS es una estrategia (Alma-Ata, 1978; Astaná, 2018); el primer nivel de atención es el espacio donde se concreta: establecimientos I-1 a I-4 del MINSA y los escenarios comunitarios.



Objetivos



OBJETIVO GENERAL

Garantizar el desarrollo comunicativo funcional y equitativo de la población, fortaleciendo las competencias lingüísticas y sociales desde edades tempranas.

Objetivos específicos



Prevenir y promover

Desarrollar acciones preventivas, educativas y terapéuticas desde la primera infancia.



Reducir brechas de acceso

Acercar la atención especializada a poblaciones periurbanas y rurales con menor cobertura.

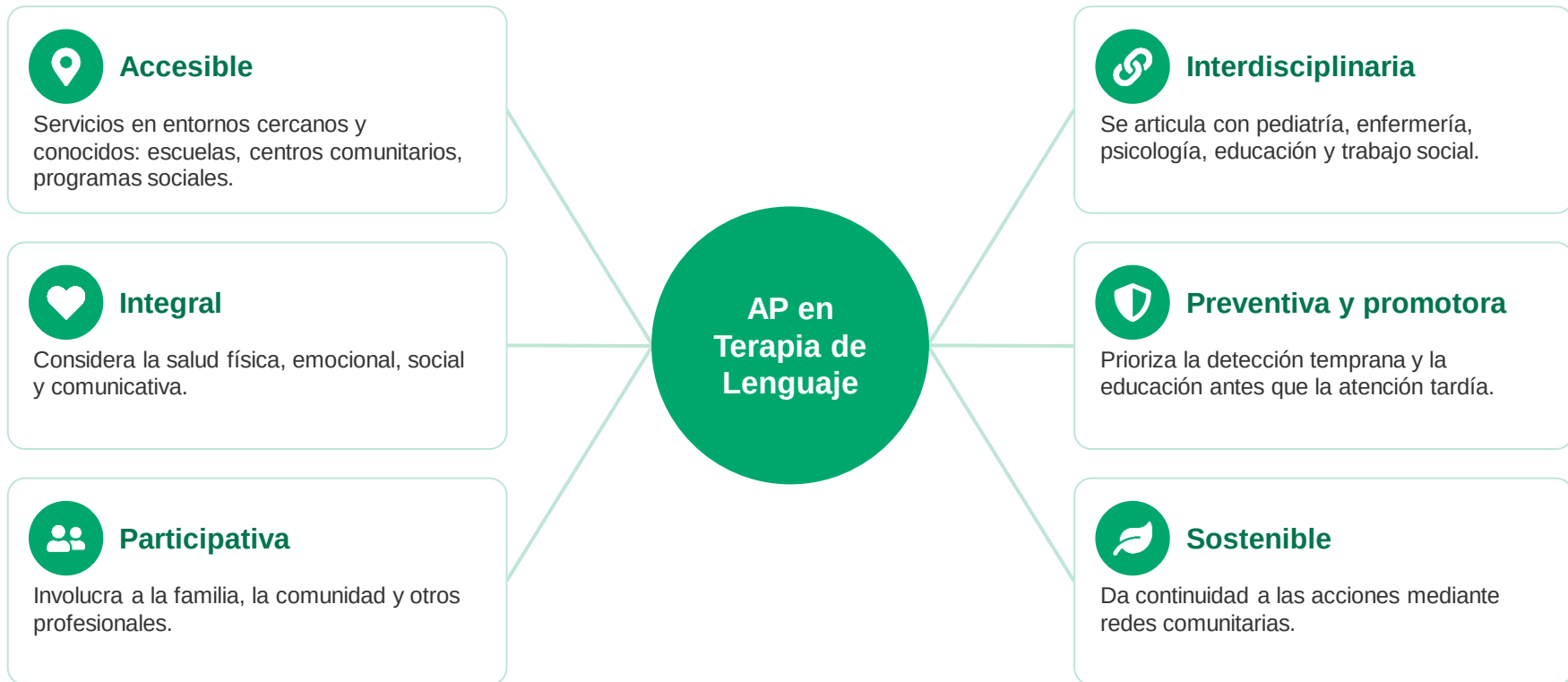


Empoderar aliados

Formar a agentes comunitarios, docentes y familias como aliados en la promoción del lenguaje y la comunicación.



Características





Características en acción



¿Cómo se ve cada característica en el trabajo comunitario del terapeuta de lenguaje?

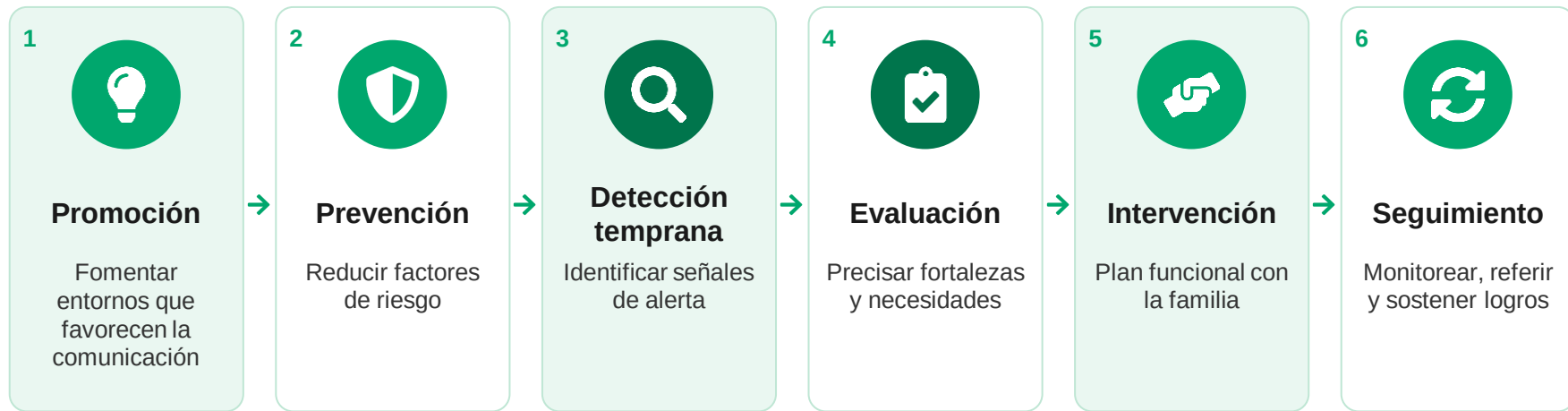
Característica	En la práctica
Accesible	Tamizajes en la I.E. inicial, el PRONOEI o el local comunal, no solo en el consultorio.
Integral	Al valorar la comunicación, considerar audición, alimentación, sueño, vínculo y contexto familiar.
Participativa	Padres y cuidadores definen metas y aplican estrategias en rutinas diarias (comida, baño, juego).
Interdisciplinaria	Coordinación con enfermería (control CRED), pediatría, psicología, docentes y trabajo social.
Preventiva y promotora	Talleres de lectura compartida y juego con familias antes de que aparezcan dificultades.
Sostenible	Formación de promotores y agentes comunitarios que continúan las acciones en el tiempo.



El continuo de la atención primaria



Las acciones del terapeuta de lenguaje en el primer nivel siguen una ruta articulada:



No es una ruta lineal: lo aprendido en el seguimiento retroalimenta las acciones de promoción y prevención en la misma comunidad.



Niveles de prevención en comunicación



Prevención PRIMARIA

Evitar que aparezca el trastorno

- Educación a gestantes y familias sobre estimulación del lenguaje
- Lectura compartida y juego en rutinas
- Cuidado auditivo: ruido, otitis, vacunación

Prevención SECUNDARIA

Detectar y actuar precozmente

- Tamizaje auditivo neonatal
- Vigilancia del desarrollo en el control CRED
- Señales de alerta identificadas en el aula

Prevención Terciaria

Reducir secuelas y favorecer la participación

- Intervención y rehabilitación en la comunidad (RBC)
- Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
- Apoyo a la inclusión escolar y social

Adaptado de Leavell y Clark (1965). En la AP comunitaria predominan las acciones de nivel primario y secundario.



Prevención y promoción



Promover la importancia del desarrollo adecuado del lenguaje y la comunicación desde la infancia, mediante actividades educativas y de sensibilización en la comunidad que reducen el riesgo de trastornos.



Charlas y talleres

A padres y cuidadores sobre estimulación del lenguaje en rutinas diarias.



Capacitación

A docentes y agentes comunitarios sobre señales de alerta comunicativas.



Materiales lúdicos

Elaborados con recursos locales y estrategias de estimulación temprana.



Desarrollo integral

Promoción del desarrollo auditivo, cognitivo y socioemocional desde los primeros años.



DetECCIÓN temprana



Identificar de manera oportuna las dificultades comunicativas en niños y adultos, lo que permite intervenciones más efectivas.



¿Dónde se realiza?



Rol del terapeuta de lenguaje: derivar o intervenir a tiempo, evitando que las dificultades se cronifiquen. Aquí se aplica lo trabajado en tamizajes (semana 5).



Señales de alerta: cuándo derivar



12 meses

- No balbucea
- No usa gestos (señalar, decir adiós)
- No responde a su nombre

16–18 meses

- No dice palabras sueltas
- No comprende órdenes simples con gesto

24 meses

- No combina dos palabras de forma espontánea
- Su habla es poco comprensible para la familia

A cualquier edad

- Pérdida de habilidades ya adquiridas
- No reacciona a sonidos o voces
- Adultos: dificultad súbita para hablar o comprender (urgencia)



Referencial. Contrastar con la NTS N.º 137-MINSA/2017 (Control de Crecimiento y Desarrollo) y la bibliografía del curso antes de su uso formal.



Evaluación



Contextualizada

Funcional

Culturalmente pertinente

¿Qué incluye?

- Entrevistas a padres y docentes
- Observación del niño en actividades naturales
- Instrumentos estandarizados o adaptados al contexto local
- Evaluación más detallada cuando el tamizaje sugiere un posible trastorno

Áreas que se valoran



Comprensión



Expresión



Articulación



Fluidez



Voz



Pragmática

Pertinencia cultural: en familias bilingües (p. ej. quechua–castellano) se evalúa en ambas lenguas; el bilingüismo no es un trastorno. Objetivo: identificar fortalezas y necesidades para un plan ajustado al entorno familiar y escolar.



Intervención y tratamiento



Planes individualizados que favorecen una comunicación funcional y significativa, con estrategias:



Lúdicas y vivenciales

El juego y las rutinas como contexto de aprendizaje.



Grupales cuando es posible

Sesiones comunitarias que fortalecen el aprendizaje cooperativo.



Familia co-terapeuta

Padres y cuidadores aplican estrategias en casa.



Recursos locales

Materiales naturales y disponibles en la comunidad.



Seguimiento continuo

Evaluación permanente del progreso.



Generalización

Los logros se trasladan al hogar, la escuela y la comunidad.

Escenarios de intervención



Domicilio



Institución educativa



Establecimiento de salud



Espacio comunitario



Referencia y contrarreferencia



Primer nivel

- Comunidad, I.E., programas sociales
- Establecimientos I-1 a I-4
- Promoción, prevención, detección, intervención y seguimiento



REFERENCIA

cuando se requiere evaluación o tratamiento especializado



CONTRARREFERENCIA

retorno con indicaciones para la continuidad



Niveles II y III

- Hospitales e institutos especializados
- Audiología, ORL, neuropediatría, cirugía de fisura
- Diagnóstico y tratamiento especializado

El terapeuta de lenguaje en el primer nivel registra, deriva oportunamente, coordina con la red y sostiene la intervención en la comunidad.



Caso aplicado



Mateo, 2 años y 6 meses

Asiste a un servicio de Cuna Más en un asentamiento humano de Lima Norte. Su madre comenta que «dice muy pocas palabras» y que a veces no voltear cuando lo llaman. En casa se habla quechua y castellano. Sus controles CRED están incompletos y no tiene registro de tamizaje auditivo.

En equipos, respondan:

- 1 ¿Qué señales de alerta identifican?
- 2 ¿Qué acciones de detección realizarían y dónde?
- 3 ¿Cómo harían una evaluación culturalmente pertinente?
- 4 ¿A quién derivarían y con quién se articularían?
- 5 ¿Qué estrategias propondrían a la familia y a la Cuna?



Actividad: diseñemos la ruta de atención



1

Analicen el caso de Mateo e identifiquen riesgos y señales de alerta.

2

Tracen la ruta: promoción → prevención → detección → evaluación → intervención → seguimiento.

3

Señalen en cada paso quién actúa (TL, familia, docente, enfermería) y dónde.

4

Redacten un mensaje clave para la familia como mini-infografía (lo trabajado en la semana 6).



Tiempo

25 min en equipos + 10 min de plenario



Modalidad

Equipos de 4 a 5 estudiantes



Producto

Esquema de la ruta + mini-infografía para la familia



Evidencia

Se incorpora al portafolio digital del curso



Ideas fuerza



1

La AP acerca al terapeuta de lenguaje a donde las personas viven, aprenden y se desarrollan.

2

Promover, prevenir y detectar a tiempo evita que las dificultades se cronifiquen.

3

La familia y la comunidad son aliadas: co-terapeutas y agentes de sostenibilidad.



La atención primaria es esencial para un sistema de salud eficiente, equitativo y centrado en las personas: brinda cuidado preventivo y resolución temprana para evitar complicaciones. El terapeuta de lenguaje es parte de ese primer contacto.



Comentarios

¿Qué acción de atención primaria podrías implementar en tu centro de prácticas?



Referencias



Ministerio de Salud del Perú. (2017). NTS N.º 137-MINSA/2017/DGIESP. Norma técnica de salud para el control del crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menores de cinco años. MINSA.

Ministerio de Salud del Perú. (2020). Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI). MINSA.

Organización Mundial de la Salud. (1978). Declaración de Alma-Ata. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.

Organización Mundial de la Salud y UNICEF. (2018). Declaración de Astaná. Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud.

OMS, UNESCO, OIT e IDDC. (2012). Rehabilitación Basada en la Comunidad: Guías para la RBC (ed. original en inglés, 2010). Organización Mundial de la Salud.

Leavell, H. R. y Clark, E. G. (1965). Preventive medicine for the doctor in his community (3.^a ed.). McGraw-Hill.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**FACULTAD DE
TECNOLOGÍA MÉDICA**

**TERAPIA DE AUDICIÓN, VOZ
Y LENGUAJE**